

Cementado de corona provisional de PMMA fresado CAD/CAM

v0.4 · borrador · borrador sin revisión de especialista · 2026-10-06

Fuentes, el porqué de cada paso y la versión vigente
criterium-e5d90.web.app/#proto/cementado-pmma



PIEZA	MATERIAL Y LOTE DEL BLOQUE	VÍA (CONVENCIONAL / ADHESIVA)	CEMENTO
-------	----------------------------	-------------------------------	---------

PASO A PASO

01 ☐ Confirma de qué material es la corona

Confirma con el laboratorio el material exacto antes de tocar la corona.

02 ☐ Elige la vía de cementación antes de preparar nada

Elige la vía ahora: cements con óxido de zinc sin eugenol. → *si el provisional durará menos de 12 meses, el muñón es alto y retentivo y la definitiva irá adherida*

03 ☐ Mide la férula si el pilar está endodonciado

Mide con sonda milimetrada la dentina sana que queda por debajo del margen de la corona, en todo el perímetro. → *solo si el pilar está endodonciado y llevará poste*

04 ☐ Retira el provisional anterior y prueba en seco

Retira el provisional anterior, elimina todo resto de cemento del muñón y prueba la corona en boca antes de preparar nada.

05 ☐ Ajusta la oclusión sin cementar

Ajusta la oclusión con el provisional todavía sin cementar.

06 ☐ Pule solo lo que ajustaste

Pule solo las zonas que ajustaste. No pulas el resto del provisional.

07 ☐ Vía convencional: cements sin eugenol en disputa

Carga el cemento de óxido de zinc sin eugenol en una capa fina sobre la cara interna, sin llenar la cofia. → *vía convencional, cuando la definitiva se cementará con un cemento resinoso*

08 ☐ Vía adhesiva: arena la cara interna y primala con MMA

Descontamina la cara interna con ácido ortofosfórico al 37 % durante 60 segundos, lava y seca. Después arena con óxido de aluminio de 50 µm a 1–2 bar, limpia en ultrasonido y aplica una capa fina de primer con MMA. → *vía adhesiva, fuera de la boca*

09 ☐ Vía adhesiva: acondiciona el muñón y cements con resina

Aísla, graba esmalte 30 segundos y dentina 15, aplica el adhesivo frotando 20 segundos, evapora el disolvente 5 segundos y cements con resina. → *vía adhesiva, una corona a la vez*

10 ☐ Asienta y retira el exceso en el momento justo

Asienta con presión digital firme y sostenida, con vibración suave, hasta el asentamiento completo, y retira el exceso en el momento justo.

11 ☐ Revisa el margen con sonda y pasa hilo

Revisa el margen con sonda cara por cara y pasa hilo dental por ambos contactos en vaivén, sacándolo hacia vestibular.

12 ☐ Sella toda superficie que hayas fresado

Repule con fresa de acrílico, discos y pasta, y aplica un recubrimiento de superficie fotopolimerizable sobre la cara vestibular. → *si la permanencia prevista pasa de 6 meses*

13 ☐ Indicaciones, ficha y controles

Da las indicaciones al paciente, registra en ficha y deja agendado el control.

INSTRUMENTAL

ANTES DE SENTAR AL PACIENTE

- ☐ Registro del bloque: material, marca y lote
- ☐ Sonda periodontal milimetrada
- ☐ Radiografía periapical basal del pilar
- ☐ Radiómetro para comprobar la lámpara

PRUEBA Y AJUSTE

- ☐ Papel de articular y pinza
- ☐ Fresas de pulido para acrílico
- ☐ Discos y puntas de silicona
- ☐ Hilo dental
- ☐ Sonda de exploración

VÍA CONVENCIONAL

- ☐ Cemento de óxido de zinc sin eugenol
- ☐ Loleta y espátula de cemento
- ☐ Rollos de algodón para aislamiento relativo

VÍA ADHESIVA

- ☐ Arenador con óxido de aluminio de 50 µm y manómetro
- ☐ Ácido ortofosfórico al 37 %
- ☐ Baño ultrasónico y alcohol de 96 %
- ☐ Primer con MMA
- ☐ Cemento de resina y su adhesivo
- ☐ Microbrushes y pinceles desechables
- ☐ Dique de goma, o hilo retractor y aspiración
- ☐ Cinta de teflón o matriz para proximal
- ☐ Lámpara de fotopolimerización
- ☐ Gel de glicerina

ACABADO Y CIERRE

- ☐ Hilo dental y superfloss
- ☐ Papel de articular de 40 µm
- ☐ Pasta de pulido para resina
- ☐ Recubrimiento de superficie fotopolimerizable
- ☐ Ficha clínica y agenda de controles

EN DISPUTA

07 La evidencia de 2023 contradice la práctica establecida. Pendiente de resolución por el panel de expertos.